RG Scoliosemåling LAB 3 Moss

Endring siden forrige versjon
Nytt dokument

Indikasjon	Scoliose Strukturelle forandringer i skjelettet eller bløtdeler Benlengdeforskjell	Stående Front (standard)
		Stående Side: Ved 1. gangs undersøkelse, der det ikke finnes gamle bilder På opererte med metallfiksasjon

Front		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ved **første gangs** undersøkelse starter vi lenger ned og blender ut slik at vi får med toppen av caput femoris. Dette for å avdekke evt. benlengdeforskjell. Ved **senere undersøkelser** tas kun front, og mer innblendet (tilsvarende ca. ¾ virvelbredde på hver side av columna). OBS! Ikke blend så mye inn at du kutter evt. stor scoliose Front viser scoliose.	
POSISJONERING	Tas i AP. Pasienten står barbeint på gulvet, med stativet plassert mellom seg og veggbucky. Lik tyngde på begge bein. Hælene godt bakover, og ikke lene seg mot stativet. Armene ned langs siden. Avslappet posisjon, ikke unaturlig oppretting. Pasienten puster rolig. Dersom pasienten vanligvis bruker oppbygg i skoen, skal det ved hjelp av avdelingens klosser bygges opp til caput femoris står på linje. Teip fast en **<u>blylinjal</u>** i strålefeltet horisontalt, ca. midt i IS-ledd.	
SENTRERING	Pasienten posisjoneres midt i strålefeltet. Klikk på **S-Guide** for å få frem kameraet. Blend ut i bredden ved å bruke ikoner for inn/utblending som er lokalisert under bildet du ser. Still deretter inn i høyden ved hjelp av linjene i bildet. Du vil da se om det trengs 2,3 eller 4 eksponeringer, alt etter høyden på pasienten. Når alt er klart klikker du **Set,** deretter **Apply**. Røntgenrør og veggbucky stiller seg da inn, og vil flytte seg underveis i eksponeringen. Hold eksponeringsknappen inne til alle bildene er tatt. Under eksponeringen kommer det opp ett og ett bilde, disse vil stitches sammen til ett bilde automatisk når eksponeringen er ferdig. Bildetakingen er ovenfra og ned.	
STRÅLERETNING	0° FFA 200 cm (Liggende bilder har FFA 110 cm)	
BILDEKRITERIER	Ved 1.gangs undersøkelse skal columna fremstilles fra C6 til og med toppen av caput femoris. Ved senere undersøkelser skal columna fremstilles fra C6 til midt i ileosacralleddene.	
KOMMENTAR	Vurder bildene før de godkjennes; har pasienten flyttet seg, vært urolig? Noe kan fikses med postprosessering, men om det er for mye bevegelse må serien tas på nytt. Det er kun den stitchede serien som går over i PACS. Om ønskelig er det mulig å få enkeltbildene også over. Kontakt Tone eller June, så kan dette ordnes i etterkant. **Korsettbehandling:** bilder med og uten korsett. Følg det som står på henvisningen. Dersom pasienten ikke kan stå, tas bilder sittende (med minimal støtte) eller liggende. **NB!** Skriv på bildene om de er tatt sittende, liggende, med eller uten korsett.	

	Teksten «stående» kommer automatisk opp på bildene, og denne må da slettes.	
Side		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Tas rutinemessig ved **første gangs** undersøkelse, dersom det ikke finnes gamle bilder. Side viser kyfose og lordose.	
POSISJONERING	Pasienten skal stå naturlig, lik tyngde på beina. Ikke lene seg mot stativet. Venstre (helst) side inn mot stativet og armene løftes 90 grader (ikke mer). Pasienten skal ikke lene seg bakover. **Blylinjal** på samme sted som på frontbildet. (midt i IS-ledd) Gjerne holde pusten under eksponering, men om det ikke går; puste helt rolig.	
SENTRERING	Få columna sånn høvelig midt i strålefeltet, og vurder kurvaturen. Klikk på S-Guide for å få frem kameraet. Her vil innblendingen fra frontbildet komme opp automatisk, så vurder om det trengs justeringer. (endre innblending i høyden f.eks.) Når du er fornøyd klikker du **Set** og **Apply**, og det er klart for eksponering. Røntgenrør og veggbucky stiller seg da inn, og vil flytte seg underveis i eksponeringen. Hold eksponeringsknappen inne til alle bildene er tatt. Under eksponeringen kommer det opp ett og ett bilde, disse vil stitches sammen til ett bilde automatisk når eksponeringen er ferdig. Bildetakingen er ovenfra og ned.	
STRÅLERETNING	0° FFA 200 cm (Liggende bilder har FFA 110 cm)	
BILDEKRITERIER	Columna fremstilles fra C6 til midt i ileosacralledd	
KOMMENTAR	Vurder bildene før de godkjennes; har pasienten flyttet seg, vært urolig? Noe kan fikses med postprosessering, men om det er for mye bevegelse må serien tas på nytt. Det er kun den stitchede serien som går over i PACS. Om ønskelig er det mulig å få enkeltbildene også over. Kontakt Tone eller June, så kan dette ordnes i etterkant. **Korsettbehandling:** bilder med og uten korsett. Følg det som står på henvisningen. Dersom pasienten ikke kan stå, tas bilder sittende (med minimal støtte) eller liggende. **NB!** Skriv på bildene om de er tatt liggende, sittende, med eller uten korsett. Teksten «stående» kommer automatisk opp på bildene, og denne må da slettes.	

Bildene sendes til PACS x 2

Fremgangsmåte og bearbeiding av bilder

Send originalbildene til PACS.

Om du ønsker å gjøre endringer så klikk på ikonet **Extra tools**; (boks med 3 prikker), deretter på ikonet **Stitching;** (boks med 3 firkanter over hverandre med en hånd foran).

Du vil få opp bildene med overlappingen. Hold musepekeren på bildet, og juster bildet. Her vil du få opp f.eks en hel ryggvirvel som du prøver å få nøyaktig overlapping på, om det har vært litt bevegelse.

På venstre side får du opp bildene enkeltvis, og her kan du klikke på de enkelte bildene og endre svertning/kontrast i de ulike bildene. Klikk på ikonet opp til høyre med mørk/lys sol, og juster til ønsket svertning.

Når du er fornøyd, klikk **Save**.

Send bildene over til PACS.

Om du får forespørsel i etterkant går du på **Review**, finner pasienten på lista, og velger **Append.** Deretter følger du oppskriften ovenfor.

Referanser

Vedlegg

Andre kilder/litteraturliste

Slutt på Retningslinje